

TRANSPOSITION DES GROS VAISSEAUX

Signes, diagnostic

Pr RABEARIVONY Nirina

PLAN

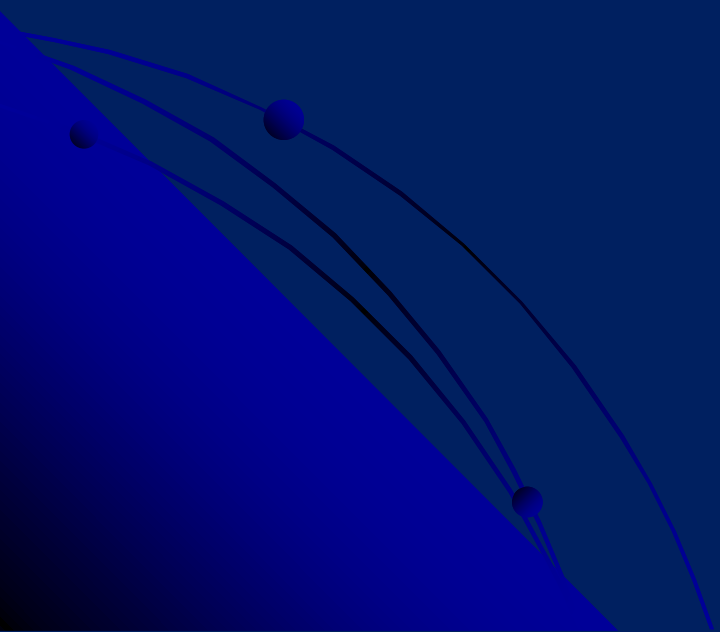
I. Généralités

II. Signes

III. Diagnostic

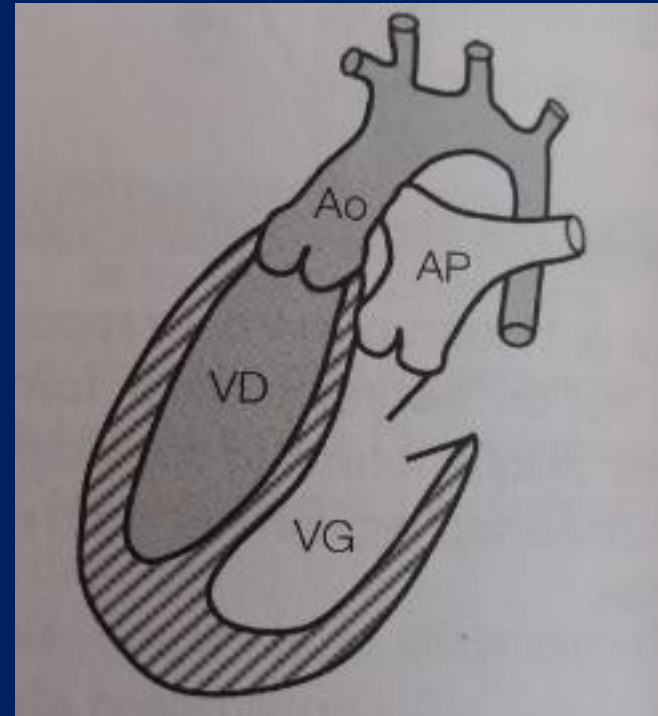
• Conclusion

I. GÉNÉRALITÉS

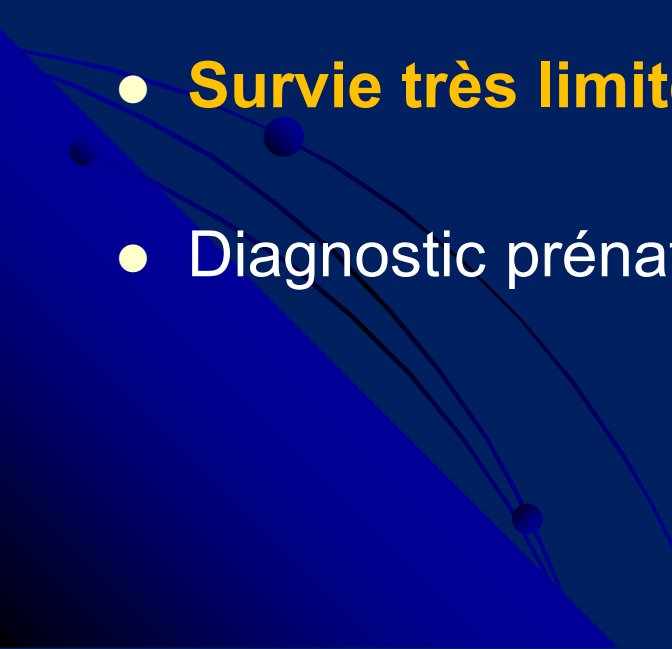


Définition anatomique

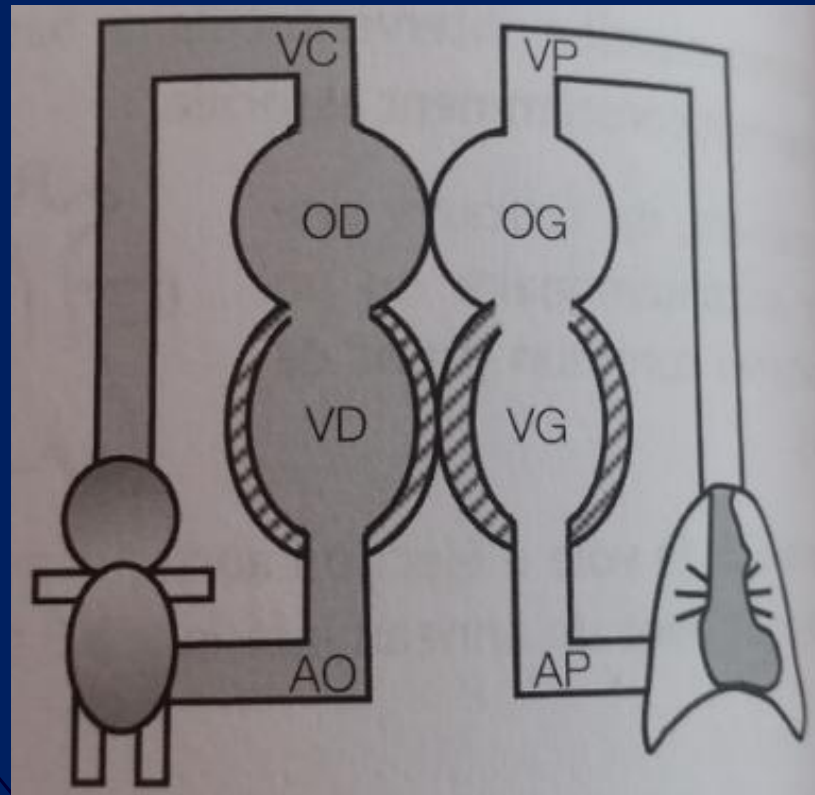
- **Discordance complète** de la **jonction ventriculo-artérielle**
- Aorte-VD, artère pulmonaire-VG
- Ao et AP parallèles et antéro-postérieurs
- Valve Ao antérieure et à droite de la VP (D-transposition)
- Circulation systémique et circulation pulmonaire **en parallèle** et non en continuité



Intérêts

- 5% des cardiopathies congénitales
- Prédomine chez les garçons (60-70%)
- **Survie très limitée sans intervention précoce**
- Diagnostic prénatal +++


Physiopathologie (1)



Survie impossible sauf si $\exists$ PCA, CIA ou CIV (30-40%)

Physiopathologie (2)

- RAP baissent pendant les 2 premières semaines de vie
 - ➔ VG perd rapidement de sa masse et s'hypotrophie
- RAS élevée
 - ➔ VD s'hypertrophie (ventricule systémique)
 - ➔ Défaillance VD à long terme

PLAN

I. Généralités

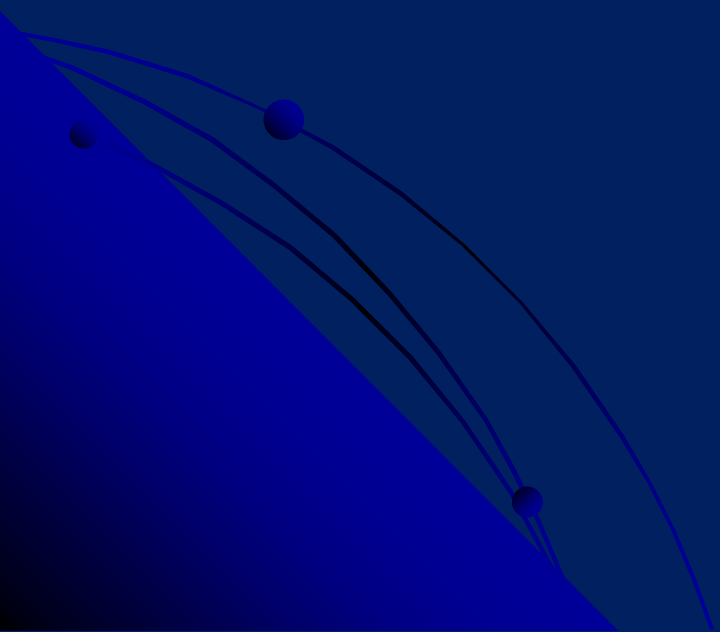
II. Signes

III. Diagnostic

• IV. Traitement

Conclusion

Type de description :
Transposition simple des gros
vaisseaux



- Transposition « simple » : non associée à d'autres malformations majeures comme
 - large CIV
 - sténose ou atrésie pulmonaire
 - coarctation

II. SIGNES

- Type de description
 - **Circonstances de découverte**
 - Signes cliniques
 - Signes paracliniques
 - Evolution et complications
 - Formes cliniques
 - Selon les anomalies associées
 - Formes selon l'inversion ventriculaire

Circonstances de découverte

- Echographie fœtale
- Cyanose
- Dyspnée si acidose
- Complications

II. SIGNES

- Type de description
 - Circonstances de découverte
 - **Signes cliniques**
 - Signes paracliniques
 - Evolution et complications
- Formes cliniques

Signes cliniques

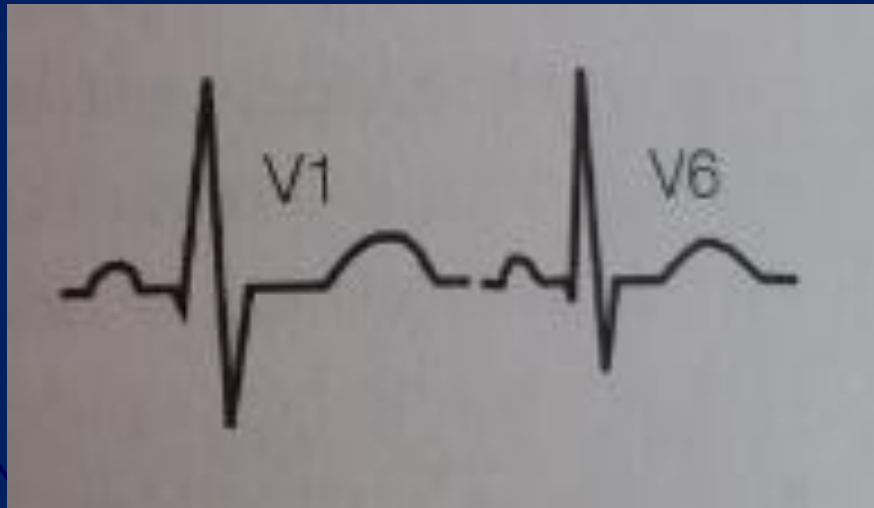
- **Cyanose** à la naissance
 - moindre dans les premières heures de vie (canal artériel et foramen ovale)
 - Rapidement intense
- **Auscultation cardiaque normale**
- **Pouls bien perçus**
- Respiration normale ou dyspnée si acidose métabolique

II. SIGNES

- Type de description
 - Circonstances de découverte
 - Signes cliniques
 - **Signes paracliniques**
 - Evolution et complications
- Formes cliniques

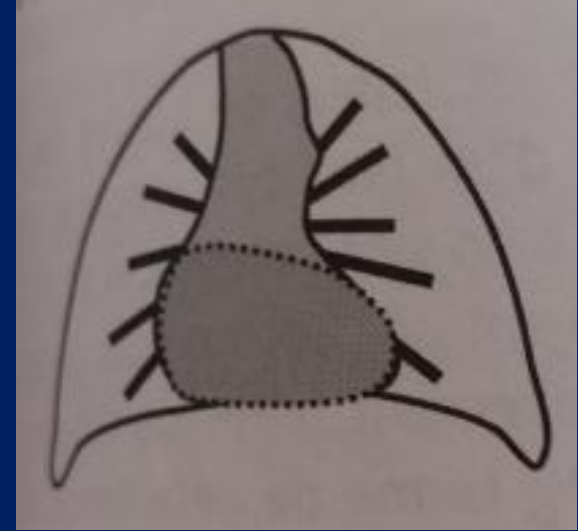
Électrocardiogramme

- Surcharge ventriculaire droit (Normal pour le nouveau-né)



Radiographie thoracique

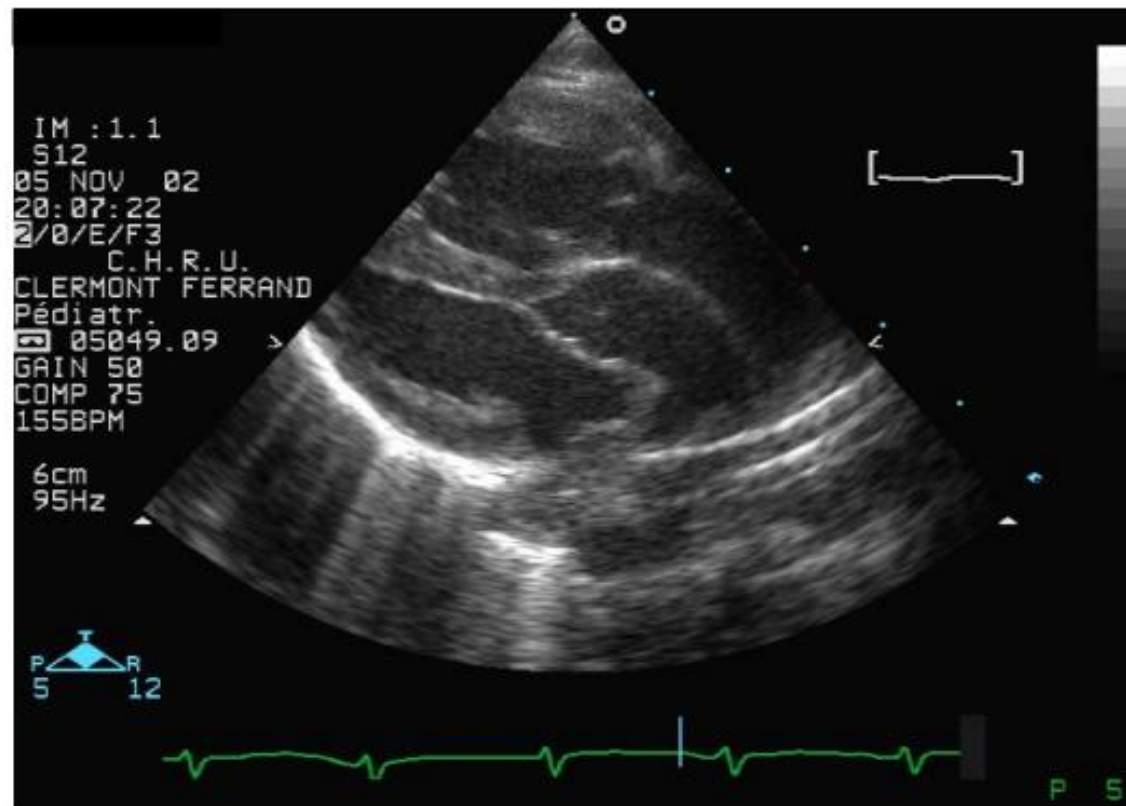
- Normale au début
- Silhouette cardiaque ovoïde
(œuf couché sur le diaphragme)
- Accentuation progressive de la vascularisation



Échocardiogramme (1)

- Naissance anormale des gros vaisseaux :
 - AP postérieure et naît du VG
 - Ao antérieure et naît du VD
 - Ao et AP parallèles
- Evaluer ouverture canal artériel et foramen ovale
- Exclure d'autres anomalies associées

- Gros vaisseaux parallèles
- Absence de croisement des gros vaisseaux.
- Coupe parasternale LA ou sous-costale LA



II. SIGNES

- Type de description
 - Circonstances de découverte
 - Signes cliniques
 - Signes paracliniques
- **Evolution et complications**
- Formes cliniques

Évolution naturelle (1)

- En l'absence de mélange sanguin suffisant : **décès** rapide (en quelques heures) par **acidose métabolique**
- En cas de mélange sanguin (CA, FO) : survie de quelques heures
- En cas de foramen ovale peu perméable : intolérance quasi-immédiate

Évolution si opérée (2)

- Favorable avec bon pronostic à court et moyen terme
- Survie +/- longue selon le type d'intervention
- Mortalité péri-opératoire < 5% si « switch artériel »

II. SIGNES

- Type de description
 - Circonstances de découverte
 - Signes cliniques
 - Signes paracliniques
 - Evolution et complications
- Formes cliniques
 - **Selon anomalies associées**
 - Selon inversion ventriculaire

Formes cliniques selon anomalies associées (1)

- TGV simple : TGV sans autres anomalies
- TGV associée à :
 - CIV
 - CIA
 - Obstruction CCVG ...

II. SIGNES

- Type de description
 - Circonstances de découverte
 - Signes cliniques
 - Signes paracliniques
 - Evolution et complications
- Formes cliniques
 - Selon anomalies associées
 - **Selon inversion ventriculaire**

TGV naturellement corrigée (1)

- TGV + ventricules également inversés
- **Discordance auriculo-ventriculaire** + discordance ventriculo-artérielle
- Trajet du sang : **OD** → **VG** → **AP** → **poumons** → **OG** → **VD** → **Ao**
- Pas de cyanose, souvent asymptomatique dans l'enfance
- Problème : ventricule systémique = VD

TGV naturellement corrigée (2)

- Survie devient possible
- Ventricule anatomiquement droit se retrouve en position sous-aortique
 - Fonctionne comme ventricule systémique
 - Dilatation VD
 - IT sévère
 - IVD vers 20-25 ans

TGV naturellement corrigée (3)

- Symptomatique chez l'enfant si
 - VD défaillant prématurément
 - Cyanose due à une CIV avec sténose de la CCVG
- qui entraîne un shunt D-G

PLAN

I. Généralités

II. Signes

III. Diagnostic

• IV. Traitement

Conclusion

DIAGNOSTIC

- **Diagnostic positif**
- Diagnostic différentiel
- Diagnostic étiologique

Diagnostic positif (1)

- **Posé devant :**
 - Cyanose ne répondant que faiblement à l'O₂
 - Absence de souffle cardiaque
 - Caractéristiques radiologiques thoraciques

Diagnostic positif (2)

- **Confirmé par l'imagerie**

- Echocardiographie doppler :

→ anomalies caractéristiques

Diagnostic prénatal

- Échographie du fœtus vers la 22è SA
- Rechercher autres malformations
- **Avantages :**
 - organiser naissance (équipe de cardiologie pédiatrique)
 - éviter une cyanose trop importante et ses conséquences néfastes
 - diminuer mortalité autour de l'opération

DIAGNOSTIC

- Diagnostic positif
- **Diagnostic différentiel**
- Diagnostic étiologique

Diagnostic différentiel

- **Autres cardiopathies cyanogènes**

- Tétralogie de Fallot
- Tronc artériel commun
- Atrésie pulmonaire à SIV intact
- Atrésie tricuspide
- Maladie d'Ebstein

DIAGNOSTIC

- Diagnostic positif
- Diagnostic différentiel
- **Diagnostic étiologique**

Diagnostic étiologique

- Congénitale
- Cause inconnue
- Peu de formes familiales

Conclusion

- **Diagnostic anténatal +++**
- Cyanose isolée
- A la naissance : **urgence diagnostique et thérapeutique**, milieu spécialisé
- Bon pronostic si traitée